

CONDUCTA SUICIDA EN URGENCIAS. INTENTO AUTOLÍTICO

Antonio Serrano Garcia

INTRODUCCIÓN

La presencia de ideación o conducta suicida suele ser una de las situaciones más frecuentes en los Servicios de Urgencias de cualquier hospital. Si bien el cuadro que recibimos en Urgencias consiste en un paciente que tiene idea o ha realizado alguna acción encaminada a acabar con su vida, esto constituye el final de un proceso que ha llevado al paciente a esta determinación y es necesario abordarlo desde una perspectiva integradora teniendo en cuenta factores biológicos, psicológicos y sociales.

DIAGNÓSTICO

El paciente puede relatar espontáneamente que desea acabar con su vida o puede ser traído al hospital tras la realización de un gesto autolítico, sin embargo, la presencia de suicidabilidad no siempre es evidente y suele ser difícil identificarla. La presencia de quejas somáticas poco específicas en un paciente con factores de riesgo debe hacer sospechar al clínico el riesgo de que aparezca una conducta suicida. Igualmente se debe estar especialmente vigilante ante la posibilidad de conducta suicida en niños y adolescentes.

Entre estos factores de riesgo destacan:

- Varón
- Vive solo
- Abuso de alcohol
- Gestos autolíticos previos
- Problemas económicos o sociales
- Presencia de enfermedad grave o incurable
- Una vez detectada la presencia de suicidabilidad es preciso caracterizarla. Para ello es necesario una exploración detallada que permita comprender el proceso que ha desembocado en la conducta suicida. Es preciso obtener toda la información posible sobre el paciente y su entorno para lograr comprender de la forma más completa el proceso ante el que nos encontramos. Antes de finalizar la exploración debemos ser capaces de responder a las siguientes cuestiones:
 - Desencadenante: ¿Cuál ha sido el motivo último que ha desencadenado la conducta suicida o la decisión de acudir a Urgencias para pedir ayuda?
 - Planificación: ¿El paciente ha planeado meticulosamente su suicidio o la conducta responde a un impulso pasajero?
 - Letalidad: ¿Los medios que el paciente ha utilizado o planea utilizar son probablemente capaces de causar la muerte?
 - Expectativa de rescate: ¿El paciente ha dispuesto la situación de tal manera que es probable que alguien le proporcione ayuda que impida su muerte?
 - Juicio de realidad: ¿El paciente es capaz de tomar decisiones sin que su juicio se vea entorpecido por alguna enfermedad o trastorno?
 - Ganancias: ¿La conducta del paciente es finalista o mediante esta espera modificar alguna situación de su entorno?

La conducta suicida en sí misma no constituye una enfermedad psiquiátrica, sin embargo, es frecuente que aparezca en diferentes trastornos. Principalmente en Trastornos por abuso de

sustancias, Trastornos de la personalidad, Trastornos afectivos, Trastorno neuróticos y secundarios a situaciones estresantes (destacando el Trastorno Obsesivo Compulsivo) y en el grupo de los Trastornos Psicóticos.

TRATAMIENTO

Si ha existido ya una conducta suicida inicialmente es preciso controlar los efectos de ésta sobre el organismo. Por ejemplo, si ha existido una sobredosis de fármacos o drogas es preciso proporcionar los cuidados necesarios hasta que la sustancia sea eliminada del organismo. Para ello puede ser necesario administrar algún antídoto que la contrarreste, por ejemplo, flumazenilo para las benzodiazepinas o naloxona para los opiáceos. En casos severos puede requerirse ingreso en UCI.

Independientemente del método mediante el cual el paciente ha tratado de acabar con su vida puede ser necesaria una estancia en observación, no sólo por una cuestión biológica, sino porque el paciente acaba de realizar una acción que puede ser traumática en sí misma y puede ser recomendable que el paciente tenga unas horas para reflexionar sobre su conducta.

Tras haber controlado el cuadro somático y establecido la pausa que se considere necesaria puede ser necesario solicitar la valoración del Servicio de Psiquiatría, que decidirá si es necesaria una hospitalización o el cuadro debe abordarse de forma ambulatoria.

IMPORTANTE

- Ante una conducta suicida lo primero es estabilizar al paciente orgánicamente.

BIBLIOGRAFÍA

- Miller L. Suicide intervention: basic processes and strategies. Int J Emerg Ment Health. 2011;13(1):37-42.
- Silverman MM, Berman AL. Suicide risk assessment and risk formulation part I: a focus on suicide ideation in assessing suicide risk. Suicide Life Threat Behav. agosto de 2014;44(4):420-31.
- Pelkonen M, Marttunen M. Child and adolescent suicide: epidemiology, risk factors, and approaches to prevention. Paediatr Drugs. 2003;5(4):243-65.